

Hot Topics Obesità Infantile - SIEDP

Prevenzione dell'Obesità Infantile: Linee Guida e Protagonisti

1. Principi Generali e Protagonisti della Prevenzione

L'obesità è una patologia multifattoriale: l'intervento preventivo deve agire su tutti i fattori causali per modificare i determinanti ambientali e sociali.

- **Intersettorialità:** Le azioni devono essere multicomponenti, basate su alleanze tra Aziende Sanitarie e partner locali (Comuni, scuole, associazioni sportive, produttori alimentari e ditte di ristorazione).
- **Continuità temporale:** La prevenzione primaria deve iniziare in gravidanza e proseguire nelle età prescolare e scolare.
- **Livello individuale:** Coinvolgimento di pediatri, nutrizionisti ed endocrinologi.
- **Livello collettivo:** Intervento del SIAN (Dipartimento di Prevenzione), scuole, insegnanti e famiglie.

2. Prevenzione in Gravidanza

È fondamentale che la gestante sia seguita da un team multidisciplinare (ginecologo, ostetrica, psicologo, nutrizionista, pediatra).

- **Peso corporeo:** Raggiungere un peso ottimale prima del concepimento e mantenere un aumento ponderale appropriato durante i nove mesi.
- **Monitoraggio:** Controllo costante della crescita fetale e dell'apporto energetico/nutrizionale materno.
- **Stile di vita:** Educazione nutrizionale e attività fisica moderata.
- **Diabete gestazionale:** Alimentazione normocalorica a basso indice glicemico e controlli glicemici frequenti.

3. Prevenzione da 0 a 3 Anni

Il Ruolo del Pediatra

- **Monitoraggio Auxologico:** Almeno 7 controlli nel primo anno, 4 nel secondo, poi semestrali per monitorare la curva del BMI.
- **Soggetti a rischio:** Attenzione particolare ai nati piccoli (SGA), nati macrosomi (>4000g), figli di genitori obesi o con storie di malattie cardiovascolari/metaboliche.
- **Alimentazione:** Promuovere l'allattamento al seno (6 mesi e oltre) e il divezzamento dopo i 6 mesi (mai prima dei 4).

- **Composizione dei pasti:**
 - **Proteine:** 6-8% delle calorie totali (6-12 mesi); 10-12% successivamente. Evitare l'eccesso proteico.
 - **Lipidi:** 50% delle calorie nei primi 6 mesi, arrivando gradualmente al 30% a 3 anni.
 - **Carboidrati e fibre:** Introdurre carboidrati complessi sin dallo svezzamento.
- **Abitudini:** Suddividere la giornata in 4-5 pasti. Sospendere il biberon tra i 18 e i 24 mesi (usare la tazza dopo i 2 anni). Evitare tassativamente bevande zuccherate.

Il Ruolo dei Genitori

- **Allattamento e Latte:** Promuovere il latte materno. In alternativa, usare latte artificiale a ridotto apporto proteico (max 500ml/die dopo il 6° mese).
- **Cibo e Famiglia:** Consumare la colazione insieme. Preparare alimenti freschi e stagionali in casa, limitando condimenti e sale.
- **Educazione al gusto:** Evitare zucchero e sale fino ad almeno 1 anno. Evitare formaggini e cibi conservati.
- **Relazione con il cibo:** Non usare il cibo come premio o castigo. Rispettare i segnali di sazietà del bambino.
- **Riposo e Sedentarietà:** Assicurare 8 ore di sonno. Evitare schermi (TV, smartphone) fino a 2 anni (max 1 ora dopo i 2 anni). No TV in camera o durante i pasti.
- **Movimento:** Ridurre l'uso del passeggino dai 2 anni. Incentivare giochi di movimento e passeggiate in famiglia.

4. Prevenzione in Età Prescolare e Scolare

Il Ruolo del Pediatra

- **Controlli:** Proseguire i bilanci di salute programmati con focus sulla familiarità per obesità.
- **Modello alimentare:** Promuovere la Dieta Mediterranea e la suddivisione calorica giornaliera:
 - Colazione: 15-20%
 - Spuntino mattina: 5%
 - Pranzo: 35-40%
 - Merenda pomeriggio: 10%
 - Cena: 30-35%

- **Educazione:** Incentivare il consumo di 5 porzioni al giorno di frutta e verdura e legumi 3-4 volte a settimana. Insegnare a bere acqua per soddisfare la sete.

Il Ruolo dei Genitori

- **Abitudini quotidiane:** Consumare una colazione adeguata. Proporre spuntini sani (frutta, yogurt, piccoli panini integrali o dolci fatti in casa).
- **Consapevolezza alimentare:** Fare la spesa insieme ai figli, leggendo le etichette e scegliendo prodotti a Km 0. Coinvolgere i bambini in cucina per sperimentare nuove ricette (specialmente con verdure e pesce).
- **Gestione del pasto:** Riconoscere i segnali di fame/sazietà senza forzare il bambino. Limitare cibi ad alta densità calorica (snack, merendine) e bevande zuccherate.
- **Sale:** Utilizzare poco sale e solo se iodato. Limitare prodotti precotti e insaccati.
- **Attività fisica e Schermi:** Max 2 ore di TV/videogiochi al giorno. Promuovere sport organizzati (2-3 volte/settimana per 50-60 minuti) a partire dai 4-5 anni e incentivare spostamenti attivi (piedibus).

Ecco il testo riordinato, formattato in Markdown per renderlo "AI-friendly" e ripulito dai numeri di riferimento bibliografico. Non ho modificato né tagliato alcuna parola del contenuto originale:

Diagnosi differenziale di obesità

QUANDO VANNO RICERCATE LE CAUSE SECONDARIE DI OBESITÀ?

In presenza di un quadro clinico di obesità in età pediatrica e adolescenziale bisogna sempre escludere le forme di obesità secondaria (circa il 2-3% dei casi), dovute ad una causa ben identificabile quali le endocrinopatie, le anomalie genetiche legate ad alterazioni cromosomiche oppure a mutazioni monogeniche, le patologie organiche del sistema nervoso centrale e le forme iatrogene.

Il sospetto clinico di obesità secondaria deve sorgere dopo un'attenta valutazione anamnestica, antropometrica e clinica. In questi casi, infatti, l'obesità si associa a segni e/o sintomi specifici della patologia di base (particolare attenzione ai casi con obesità e bassa statura, ritardo cognitivo, dismorfismi facciali). In tutti questi casi la diagnosi eziologica è di estrema importanza, in quanto un adeguato trattamento della patologia primitiva può consentire un netto miglioramento dell'eccesso ponderale ed una presa in carico precoce delle patologie associate.

QUALI SONO I CARATTERI CLINICI DELLE PRINCIPALI CAUSE SECONDARIE DI OBESITÀ?

- **Endocrinopatie:** (ipotiroidismo, ipercorticosurrenalismo, deficit di GH, insulinoma, pseudoipoparatiroidismo, nesidioblastosi).

- *Sintomi:* bassa statura e/o progressivo rallentamento della velocità di crescita, cute sottile ed atrofica con strie rubre ingravescenti, obesità tronculare, ipertensione arteriosa, alterazioni mestruali, segni di iperandrogenismo, ipoglicemia neonatale.
- **Obesità monogeniche dovute a singole mutazioni geniche:** deficit congenito di leptina, mutazione del gene del recettore della leptina, del gene della pro-opiomelanocortina (POMC), del gene della proormone convertasi 1 (PC1), del recettore della melanocortina (MC4-R). Le obesità monogeniche, per quanto non comuni, rappresentano attualmente le cause di obesità ad esordio precoce di gran lunga più frequenti rispetto alle cause endocrine e ancor di più rispetto a quelle sindromiche.
 - *Sintomi:* l'obesità di grado elevato e ad insorgenza precoce (nei primi 3 anni di vita) costituisce il sintomo principale in assenza di note dismorfiche facciali; in alcuni casi è presente insufficienza surrenalica, capelli rossi, ipogonadismo ipogonadotropo, ipotiroidismo e deficit immunitari.
- **Difetti genetici associati all'obesità (obesità genetiche):** La presenza di obesità a sviluppo precoce in un bambino con deficit cognitivo, ritardo dello sviluppo psicomotorio, bassa statura, criptorchidismo o ipogonadismo, dismorfismi con facies più o meno caratteristica, alterazioni oculari e/o uditive, deve far pensare ad una forma di obesità su base sindromica che deve essere supportata da esami strumentali e specifiche indagini genetiche. La più frequente di tali condizioni è la sindrome di Prader-Willi, dovuta ad alterazione del cromosoma 15 di origine paterna, che si accompagna a grave ipotonia neonatale, suzione ipovalida, letargia ed iniziale scarso accrescimento. La presenza di disturbi della vista, quali la diminuzione della visione crepuscolare (emeralopia) fino alla cecità, l'alterazione nella visione dei colori (discromatopsia) e le alterazioni renali indirizzano verso la diagnosi di sindrome di Bardet-Biedl specie se in presenza di polidattilia. Nella diagnosi differenziale bisogna considerare la sindrome di Alström che si associa a nistagmo, distrofia retinica e sordità neurosensoriale. Altre sindromi meno frequenti sono la sindrome di Cohen, la sindrome di Carpenter, la sindrome di Borjeson-Forssman.
- **Disordini cromosomici associati a obesità:** (sindrome di Down, sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner).
- **Patologie organiche del sistema nervoso centrale:** alterazioni neuroendocrine insorte dopo traumi cranio-cerebrali, lesioni post-neurochirurgia, meningiti/encefaliti, tumori ipotalamo-ipofisari, craniofaringioma. In tale ambito deve essere esclusa la rara sindrome di Rohhadnet caratterizzata da obesità infantile a esordio rapido, disfunzione ipotalamica, ipoventilazione, disregolazione autonoma e sviluppo di tumori neurali.
 - *Sintomi:* segni non sempre specifici di ipertensione endocranica (cefalea ingravescente e/o persistente, disturbi visivi quali nistagmo, strabismo,

emianopsia, fotofobia, ridotta acuità, cecità), altri disturbi neurologici e rallentamento della velocità di crescita.

- **Obesità iatrogena:** (corticosteroidi, valproato di sodio, risperidone, fenotiazine, ciproptadina).

Ecco il testo riordinato, formattato in Markdown (perfetto per il tuo sistema RAG) e completamente ripulito dai numeri di riferimento bibliografico tra parentesi. Come sempre, non ho modificato né tagliato alcuna parola del contenuto originale:

Riabilitazione

QUANDO PENSARE AD UN INTERVENTO RIABILITATIVO NEL BAMBINO E ADOLESCENTE OBESO?

La riabilitazione rappresenta un nodo cruciale nella rete assistenziale per i soggetti con obesità grave (BMI >120% del 95° percentile delle curve di Cacciari e coll. o > 3 DS delle curve WHO) oppure in tutte le forme di obesità con BMI >95° percentile associate a complicanze significative per l'impatto clinico o per la loro potenziale irreversibilità, e cioè:

- **Ipertensione arteriosa:** (valori sistole/diastolici $\geq$ 95° centile);
- **Patologia endocrino-metabolica:** insulino-resistenza, ridotta tolleranza glucidica/diabete mellito tipo 2, dislipidemia, sindrome dell'ovaio policistico, iperuricemia;
- **Steatosi epatica o steatoepatite;**
- **Patologie gastrointestinali:** reflusso gastro-esofageo;
- **Patologie osteoarticolari:** (epifisiolisi della testa del femore, malattia di Blount, piede piatto, ginocchio valgo, scoliosi) e limitazioni della deambulazione;
- **Patologie respiratorie:** snoring, apnee ostruttive notturne, narcolessia diurna, asma;
- **Patologie psicologico-psichiatriche:** depressione, ansia, disturbi del comportamento alimentare.

QUALI SONO LE FINALITÀ DI UN INTERVENTO RIABILITATIVO PER L'OBESITÀ PEDIATRICA?

I protocolli d'intervento riabilitativo, da svolgersi a livello intensivo in regime di ricovero e/o di DH riabilitativo, sono tesi a:

- Analizzare le cause che hanno determinato l'insorgenza dell'obesità (psicologiche, sociali, familiari, ecc.);
- Impostare un percorso di tipo multidisciplinare-integrato;
- Trattare le disabilità e le comorbidità obesità-correlate attraverso la concentrazione di più interventi;

- Fare prevenzione secondaria delle ulteriori complicanze dell'obesità;
- Utilizzare terapie farmacologiche nell'ambito di specifici protocolli;
- Selezionare e preparare i soggetti candidati alla chirurgia bariatrica e provvedere al loro follow-up post-operatorio.

COME STRUTTURARE UN INTERVENTO RIABILITATIVO PER L'OBESITA' PEDIATRICA?

Il progetto riabilitativo viene delineato per ogni singolo paziente e comprende un percorso "integrato" di durata proporzionale alla situazione globale del paziente, che prevede dietoterapia ed assistenza al pasto, attività motoria individualizzata, fisiokinesiterapia (ove necessario), psicoterapia individuale e/o di gruppo.

Si proseguirà con una gestione ambulatoriale a lungo termine per garantire la continuità assistenziale necessaria per il successo e soprattutto per il mantenimento dei risultati. Per favorire un cambiamento permanente dello stile di vita dovrà essere coinvolto tutto il nucleo familiare, che adeguatamente formato, avrà un'azione di supporto/rinforzo e di continuità educativa.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO RIABILITATIVO?

Gli obiettivi del protocollo d'intervento riabilitativo si possono suddividere in quelli a breve (6 mesi) e a medio-lungo periodo (1-3 anni) e possono essere così riassunti: riduzione dell'eccesso ponderale o di massa grassa, del grasso addominale, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca dopo sforzo e di eventuali disturbi del sonno; miglioramento dei parametri metabolici alterati, dei comportamenti disfunzionali, degli aspetti psicologici legati all'eccesso di peso, della qualità della vita; mantenimento di un'adeguata attività motoria. Per ciascuno degli obiettivi dovranno essere identificati specifici indicatori di esito atti a valutare l'efficacia del progetto terapeutico-riabilitativo.